

Información Paciente

Nombre : Patricia Del Pilar Valdes Muñoz

Edad : 34a 10m 24d

Dirección : Islas Tazos 1891 V. Creta

Rut : 16.739.318-7

Fecha Nacto: 18/08/1987

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0221139

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 8492 2810

N° Epicrisis

314832

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Partos

Fecha Ingreso : 11/07/2022 05:32

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 12/07/2022 12:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

EMBARAZO 38 SSG + RUPTURA DE MEMBRANAS

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UCI

12/07/2022

Patricia del Pilar Valdes Muñoz

16.739.318-7

MOTIVO DE INGRESO A UCI

Shock mixto: cardiogénico más hipovolémico con fallo orgánico múltiple

Falla hemodinámica severa y refractaria

ECMO venoarterial

Falla respiratoria severa

Falla hematológica ¿ plaquetopenia severa

Falla renal aguda KDIGO 1

Falla metabólica ¿ acidosis metabólica

Falla hepática

Falla cardíaca

Coagulopatía

Soporte transfusional masivo

APACHE II SCORE 34

SOFA SCORE 13

Antecedentes personales

Apendicectomía

Cesárea

Historia clínica

Datos tomados de la historia clínica

Paciente con antecedentes mencionados ingresa, según dato de atención de la urgencia el 11/07/2022 a las 04:43H con diagnóstico de embarazo de 38 +6 semanas de gestación, ruptura de membranas, asintomática para síndrome hipertensivo del embarazo (SHE) y albuminuria positiva, se hospitaliza en parto.

Fecha Epicrisis : 12/07/2022 12:58

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:10

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 12-07-2022 12:58:59

Página 2 de 3

Se decide cesárea de urgencia por preeclampsia moderada, anestesia espinal, durante la revisión instrumental intercorre con inercia uterina, sangrado y caída de hematocrito desde 40% a 18.8%, requiere soporte transfusional con 2 unidades de glóbulos rojos, suma desaturación hasta 70% y requiere intubación orotraqueal. Posteriormente a la finalización del procedimiento se extuba y permanece en la recuperación de la maternidad. En horas de la tarde presenta compromiso respiratorio y requiere nuevamente intubación orotraqueal, suma hipotensión arterial e inicia adrenalina y noradrenalina por acceso venoso periférico, a las 18:30 solicitan cupo en Unidad de Cuidados Intensivos.

Evaluada por cardiología a las 19:10 en pabellón de maternidad, al momento de la evaluación: PA 60/40, ritmo sinusal 90 lpm QRS angosto, sin signos de isquemia, Sat 70% con Fio2 100% y PEEP de 10. Ecocopia cardiaca: ventrículo izquierdo aspecto dilatado, acinesia anterior y septal, hipocinesia del resto. FEVI severamente reducida +/- 15-20%. VD algo dilatado y visualmente con buena función. Leve derrame pericárdico. Líneas B difusas en ambos campos pulmonares. Impresiona como primera opción miocardiopatía periparto severa, en EPA que no ha respondido a terapia inicial con VMI y vasoactivos. no parece embolia pulmonar, no veo valvulopatías significativas, no se comporta como SDRA Se recomienda considerar terapia de soporte ventricular (ECMO VA) si condición clínica no mejora en corto plazo (1 hora). PEEP alto por edema pulmonar refractaria

Se recibe paciente en UCI, aproximadamente a las 20:00 H del 11/06/2022, en shock refractario y fallo orgánico múltiple, fría, mal perfundida, intubada, débito de contenido serohemático (compatible con EPA) por TET, sin medición de saturación de oxígeno (satuómetro no logra sensar), TA no invasiva 90/60, noradrenalina 0.2 ug Kg min y adrenalina a 0.1 ug Kg min por acceso venoso periférico, bajo normas de asepsia y antisepsia se coloca línea arterial femoral y catéter venoso central subclavio, sin incidentes, TAM 30, requiere aumento de drogas vasoactivas, inicia corticoides, requiere bicarbonato endovenoso, ecocopia con compromiso global de función sistólica a predominio de ventrículo izquierdo, anestesista cardiovascular realiza ecocardiograma transesofágico que corrobora hallazgos de ecocopia, requiere administración de calcio endovenoso y aumento de droga vasoactivas hasta 2 ug / Kg / min, se activa ECMO venoarterial, evoluciona con profundización de hipotensión arterial y bradicardia, ante paro cardiorespiratorio inminente inicia maniobras de RCP que se mantiene durante toda la canulación (aproximadamente 30 minutos), paciente sale a ECMO VA aproximadamente a las 23:30 horas; se logra disminuir drogas vasoactivas, permanece sedada hasta RASS -5, en ventilación protectora, Fio2 100%.

Evoluciona con caída de gasto cardiaco en relación con posible sangrado y coagulación intravascular diseminada con sangrado por sitios de punción, suma hiperlactacidemia progresiva, acidosis metabólica severa de difícil control, falla renal progresiva, falla hepática progresiva, falla hematológica, coagulopatía severa, saturación venosa central muy disminuida, todo esto a pesar de transfusión de hemoderivados, bicarbonato, ácido tranexámico, octaplex, ECMO VA y maniobras de reanimación con volumen y drogas vasoactivas.

SOFA SCORE 13 / mortalidad esperada > 92.5%

APACHE SCORE 34 / Mortalidad esperada 73%

A pesar del esfuerzo terapéutico, no se consigue respuesta, paciente falleció a las 08:20H del 12/07/2022

Se da aviso al servicio de Ginecología y Obstetricia sobre la muerte materna.

Diagnóstico de Egreso

CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO - Shock mixto: cardiogénico más hipovolémico con fallo orgánico múltiple

Falla hemodinámica severa y refractaria

ECMO venoarterial

Falla respiratoria severa

Falla hematológica ¿ plaquetopenia severa

Falla renal aguda KDIGO 1

Falla metabólica ¿ acidosis metabólica

Falla hepática

Falla cardiaca

Coagulopatía

Soporte transfusional masivo

APACHE II SCORE 34

SOFA SCORE 13

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDA

Fecha Epicrisis : 12/07/2022 12:58

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:10

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Plan Post Alta

SE CONFECCIONA Y ENTREGA CERTIFICADO DE DEFUNCION A LA FAMILIA

SE AVISA TELEFÓNICAMENTE AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EL DESENLACE DE LA PACIENTE

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Guillermo Molina Mancero

Médico Tratante (Staff)